

23 禁煙指導・治療 antismoking education

到達目標

- ・ニコチン依存症の病態について説明できる
- ・ニコチン依存症の診断方法について説明できる
- ・ニコチン依存症の治療法について説明できる

1 病態と疫学

喫煙によりニコチンは体内に吸収されると6～7秒で脳内のニコチン受容体に結合する、すると脳内報酬系が活性化され、ドーパミンなどの神経伝達物質が大脳辺縁系へ放出され、強い快感が生じる。ニコチンを常時摂取すると、神経伝達物質の分泌をニコチンに依存するようになり、自分で分泌する能力が低下する。そのため、喫煙できない状態が長く続いたり、禁煙すると神経伝達物質の分泌が低下し、不快なニコチン離脱症状が現れる。ニコチン離脱症状は喫煙により消失するため、次第に喫煙者は「タバコを止めたくても止められない」状態になる。このような状態をニコチン依存症という。喫煙者の約70%がニコチン依存症と推計されている¹⁾。

2 症候・身体所見

喫煙により肌の弾力と潤いが奪われ、肌がくすみ、若年から“しわ”が増える（早期老化）。歯や歯肉に色素沈着が生じ、歯周病のリスクを高める（口腔衛生不良）。さらに、喫煙者ではタバコを持つ指や爪が黄

色く変色する・腹部の内臓脂肪が多い・頭髮の脱毛や白髪が多いといった身体的特徴がみられやすい。

3 診断・検査

ニコチン依存症スクリーニングテスト「Tobacco Dependence Screener (TDS)」²⁾（表1）が5点以上であることが、ニコチン依存症の診断基準である。喫煙量や喫煙状況を客観的に確認する方法として、呼気一酸化炭素（CO）濃度検査がある。喫煙者の呼気CO濃度は8 ppm以上であり、ヘビースモーカーの場合は20 ppmを超える。

4 治療と予後

①直ちに禁煙しようと考えていること、②TDSが5点以上であること、③35歳以上の場合はブリンクマン指数（1日喫煙本数×喫煙年数）が200以上であること、④禁煙治療を受けることを文書により同意していることの4条件に該当した者に対する禁煙治療は保険給付の対象となる。その場合、禁煙治療のための標準手順書（第8.1版）³⁾に基づいて禁煙治療を行う。禁煙治療は薬物療法と行動療法を併用して行う。禁煙補助薬にはニコチン製剤（ニコチンパッチやニコチンガム）やバレニクリンがある。行動療法には禁煙開始日の決定や禁煙宣言書の署名に加え、再喫煙防止のためのセルフモニタリング、刺激統制法、逆条件付け、オペラント強化法、問題解決カウンセリング、社会技

表1 ニコチン依存症スクリーニングテスト

設問内容	はい (1点)	いいえ (0点)
問1. 自分が吸うつもりよりも、ずっと多くタバコを吸ってしまいましたか		
問2. 喫煙や本数を減らそうと試みて、できなかったことがありますか		
問3. 禁煙したり本数を減らそうとしたときに、タバコがほしくてほしくてたまらなくなることがありましたか		
問4. 禁煙したり本数を減らそうとしたときに、次のどれかがありましたか (イライラ、神経質、落ちつかない、集中しにくい、ゆううつ、頭痛、眠気、胃のむかつき、脈が遅い、手のふるえ、食欲または体重増加)		
問5. 問4でうかがった症状を消すために、またタバコを吸い始めることがありますか		
問6. 重い病気にかかったときに、タバコはよくないとわかっているのに吸うことがありますか		
問7. タバコのために自分に健康問題が起きるとわかっているのに、吸うことがありますか		
問8. タバコのために精神的問題 ^{注)} が起きるとわかっているのに吸うことがありますか		
問9. 自分はタバコに依存していると感じることはありませんか		
問10. タバコが吸えないような仕事やつきあいを避けることが何度ありましたか		

「はい」(1点)、「いいえ」(0点)で回答を求める。

「該当しない」場合、(質問4で、禁煙したり本数を減らそうとしたことがないなど)には0点を与える。

判定方法：合計点が5点以上の場合、ニコチン依存症と診断できる。

注) 禁煙や本数を減らしたときに出現する離脱症状ではなく、喫煙することによって神経質になったり、不安や抑うつなどの症状が出現している状態。

[Kawakami N, et al: Addict Behav 24: 155, 1999 より引用]